

보건복지부 고시 제2026-192호

「국민건강보험법」 제41조제3항 및 제4항, 「국민건강보험 요양급여 기준에 관한 규칙」제5조제2항에 따라「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」(보건복지부 고시 제2026-176호(2026. 8. 27.))을 다음과 같이 개정·발령합니다.

2026년 9월 29일
보건복지부장관

「요양급여의 적용기준 및 방법에 관한 세부사항」일부개정

요양급여의 적용기준 및 방법에 대한 세부사항 일부를 다음과 같이 개정한다.

Ⅱ. 약제 “[232] Cinnamon bark dry ext. 경구제(품명: 지택정75밀리그램)”를 별지 1과 같이 신설하고, “[421] Ruxolitinib phosphate 경구제(품명: 자카비정5밀리그램 등)”의 세부인정기준 및 방법의 일부를 별지 2와 같이 변경한다.

부 칙

이 고시는 2026년 10월 1일부터 시행한다.

변경대비표

[별지 1]

[232] 소화성 궤양용제			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[232] Cinnamon bark dry ext. 경구제 (품명 : 지택정75밀리그램)	<신 설>	허가사항 범위(급성 위염 및 만성 위염의 위점막 병변 개선) 내에서 투여 시 요양급여를 인정함.	○ Cinnamon bark dry ext. 경구제(품명: 지택75밀리그램)가 신규 등재 예정임에 따라 교과서, 가이드라인, 임상논문, 학회 및 전문가 의견, 제외국 평가결과 등을 참조하여 급여기준을 신설함.
※ 관련근거 · 대한민국약전, 제12개정(식약처 고시 제2023-2호, 2023.1.12.) · 위염 임상진료지침, 대한상부위장관·헬리코박터학회(2022) · 위염치료제 임상시험 가이드라인, 식품의약품안전평가원(2015) · 소화기관용제 사용 권장지침, 대한의사협회(2003) · [미발표 임상시험 결과보고서] 급성 및 만성 위염 환자에서 CKD-495의 유효성과 안전성을 비교 평가하기 위한 무작위배정, 이중눈가림, 평행설계, 다기관, 제3상 임상시험 · [미발표 임상시험 결과보고서] 급성 및 만성 위염 환자에서 CKD-495 의 유효성과 안전성을 비교 평가하기 위한 무작위배정, 이중눈가림, 평행설계, 다기관, 제2상 임상시험 · 대한소화기기능성질환운동학회(2022.12.05.) · 대한소화기학회(대소학 제2022-107호, 2022.12.12.)			

[별지 2]

[421] 항악성종양제			
구 분	세부인정기준 및 방법		사유
	현 행	개 정(안)	
[421] Ruxolitinib phosphate 경구제 (품명: 자카비정5밀리그램 등)	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. (생 략) 나. 스테로이드불응 급성 또는 만성 이식편대숙주 질환 1) (생 략) 2) 지속투여 및 투여기간 가) 지속투여 (1) (생 략) (2) 만성: 개시 3개월 이후 1개월 단위 평가에서 반응 환자 ※ 1일 용량 10mg 이하이고 부분반응 이상의 반응을 보이는 만성 환자에 한해 최대 3개월 단위로 평가 가능하며, 호전되어 중지한 환자의 재투여는 인정함	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. (현행과 같음) 나. 스테로이드불응 급성 또는 만성 이식편대숙주 질환 1) (현행과 같음) 2) 지속투여 및 투여기간 가) 지속투여 (1) (현행과 같음) (2) <u>만성: 개시 이후 3개월 단위 평가에서 반응 환자</u>	○ 교과서, 가이드라인, 임상연구문헌, 전문가 의견 등을 고려하여 ‘만성 이식편대숙주 질환’에 Ruxolitinib 경구제의 급여기준을 개선

	<u>나) 최대투여기간: 급성 최대 6개월, 만성 최대 3년</u> <u>※ 급성 투여 종료 후 만성 투여, 급성과 만성 증상이 겹치는 경우, 호전되어 중지한 환자가 재발하여 최대투여기간을 초과하여 투여하는 경우는 사례별 인정함.</u>	<u>나) 최대투여기간</u> <u>(1) 급성: 최대 6개월</u> <u>(2) 만성: 최대 3년,</u> <u>3년 이상 투여가 필요한 경우 투여 소견서를 참조하여 인정함</u> <u>※ 호전되어 중지한 환자의 재투여는 인정하며, 급성 투여 종료 후 만성 투여, 급성과 만성 증상이 겹치는 경우 사례별로 인정함.</u>	
3) (생 략)		3) (현행과 같음)	
※ 관련근거 · Goldman-Cecil Medicine, 27e, 2024_Chapter 163 HEMATOPOIETIC CELL TRANSPLANTATION · Manual of Hematopoietic Cell Transplantation and Cellular Therapies, 2024 · The EBMT Handbook, Hematopoietic Stem Cell Transplantation and Cellular Therapies, 2024_Chapter 44: Chronic Graft-Versus-Host Disease · NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Hematopoietic Cell Transplantation (HCT). Version 3.2025 · Cell Therapy Transplant Canada (CTTC) Consensus-Based Guideline 2024 for Management and Treatment of Chronic Graft-Versus-Host-Disease and Future Directions for Development, 2024 · Updates in chronic graft-versus-host disease, 2021: ASH(The American Society of Hematology) · Robert Zeiser et al, Ruxolitinib for Glucocorticoid-Refractory Chronic Graft-versus-Host Disease, N Engl J Med 2021;385:228-38. · White J et al, A Multicenter, Retrospective Study Evaluating Clinical Outcomes of Ruxolitinib Therapy In Heavily Pretreated Chronic GVHD Patients With Steroid Failure, Transplantation and Cellular Therapy 2023;29:120.e1-120.e9 · Robert Zeiser et al, Ruxolitinib in Patients With Corticosteroid-Refractory or Corticosteroid-Dependent Chronic Graft-Versus-Host Disease: 3-Year Final Analysis of the Phase III REACH3 Study, J Clin Oncol 2025;43:2566-2571 · A.M. Ferreira et al, Long-Term Follow-Up of Ruxolitinib in the Treatment of Steroid-Refractory Chronic Graft-versus-Host Disease, Transplantation and Cellular Therapy 2021;27:777.e1-777.e6.			

- CADTH
- PBAC
- NICE
- SMC